

Desnutrição · marasmo e kwashiorkor

Desnutrição grave eleva mortalidade por infecção, hipoglicemia e distúrbios eletrolíticos. Diferencie marasmo (wasting sem edema) de kwashiorkor (edema) e inicie estabilização antes da realimentação agressiva.

Marasmo vs kwashiorkor

Lembre - Marasmo vs kwashiorkor

Marasmo: emagrecimento grave, 'pele e osso', sem edema. Kwashiorkor: edema (membros/face), cabelos ralos, apatia; pode haver formas mistas (marasmo-kwashiorkor).

Fases clássicas: tratar hipoglicemia/hipotermia/infecção !' realimentação cuidadosa !' recuperação e prevenção.

Desnutricao grave - fases

Estabilizar / realimentar / seguir

Estabilizar

Glicemia / temperatura
Volume prudente
ATB se indicado

Primeiras 24-48h

Realimentar

Dieta F75 -> F100
Evitar sobrecarga
Reposar refeeding

Micronutrientes

Seguir

Catch-up ponderal
Estimulo / vínculo
Prevenir recidiva

Alta planejada

Complicações a vigiar

- Hipoglicemia e hipotermia — medir e prevenir
- Desidratação: reidratar com cuidado (evitar sobrecarga no kwashiorkor)
- Infecções ocultas; considerar ATB empírico na desnutrição grave hospitalar
- Refeeding: hipofosfatemia, hipocalcemia, hipomagnesemia

Antropometria (ideia)

Indicador | Uso

P/I (peso/idade) | Desnutrição global — menos específico

P/E (peso/estatura) | Wasting / agudo

E/I (estatura/idade) | Stunting / crônico

Perímetro braquial | Triagem rápida em campo/emergência

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não 'encha de proteína e calorias' no dia 1 da desnutrição edematosa grave. Estabilize e use fórmulas/phase apropriadas — realimentação agressiva mata por refeeding e falência cardíaca.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1